

Mida räägivad SHARE tulemused Eesti nn hallist alast

Tiina Tambaum, Luule Sakkeus, Liili Abuladze

Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus

Aastal 2004 käivitas Saksamaa vananemisökonoomika keskus (MEA) Euroopa 50+ elanike seas individuaalse vananemise, tööjātu ja tervise paneeluuringu SHARE. Selle rahvusvahelise uuringu andmed kirjeldavad inimeste vananemise individuaalset kogemust pika aja vältel, mille põhjal on võimalik otseselt seostada põhjusi tagajärgedega ning hinnata käitumismudelite ja riiklike meetmete mõju vananeva rahvastiku heaolule. Eesti osaleb uuringus aastast 2011 enam kui 7000 vasta-jaga, praegu on käimas neljanda uuringulaine ettevalmistustööd. Kõigis osalevates maades on vastajaid kokku üle 55 000.

Sotsiaaltöö 2012. aasta neljandas numbris tutvustasime uuringu ülesehitust ja eesmärgi, täna saab rääkida juba Euroopa viie laine, nende seas Eesti kahe laine tulemustest. Kõigepealt siiski peamistest faktidest, mis seda mahukat uuringut iseloomustavad.

Uuringu korraldus

Uuringulaine viiakse läbi igal teisel aastal ning küsitletakse ühtesid ja samu inimesi. Valimisse lisatakse pidevalt ka noorem, 50aastaseks saanud vanuserühm. Valim väheneb selle võrra, kuidas inimesed elavate hulgast lahkuvad. SHARE muudab unikaalseks muu hulgas see, et infot kogutakse inimese surmale eelnend 12 kuu kohta, kui leidub lähikondlasi, kes sellest rääkida teavad. Lainest

lainesse korduv põhiankeet sisaldab küsimusi järgmiste teemade kohta: füüsiline ja vaimne tervis ning tervisekäitumine; töötamine ja töölt lahkumine; abi saamine ja andmine; inimese varad, tulud ja kulud; sotsiaalne läbikäimine ja kaasatus.

Küsitlusele saab vastata oma emakeeles. Eestis kasutatakse küsitluskeeltena eesti ja vene keelt, kokku on rahvusvahelises uuringus kasutusel üle 20 keele. Ankeedi sõnastus ja tõlked on riikide vahel täielikult ühtlustatud, tänu millele on kõigi osalevate maade andmed omavahel otseselt võrreldavad.

SHARE kui sotsiaaluuringu eripära on, et subjektiivse info kõrval kogutakse iga vastaja kohta testide ja mõõtmistega ka objektiivset teavet. SHARE talletab andmed käesurve tugevuse kohta, igas teises laines mõõdetakse kopsu mahtu ning testitakse toolilt tõusmist. Füüsilise seisundi kõrval annavad sõnavara- ja mälutestid pildi inimese kognitiivsetest võimetest. Ankeeti on peidetud küsimused, millega saab objektiivselt hinnata depressiooni sümptomeid (EURO-D), samas annavad vastajad depressiooni kohta ka subjektiivse hinnangu. Nii objektiivselt (ADL, iADL) kui subjektiivselt määratakse ka tegevuspiirangud.

Äsjalõppenud laines tehti ajalugu sellega, et küsitlajad kogusid biomarkereid. Kuiva veretilga meetodil kogutud vereproovid (DBS) võimaldavad edaspidi siduda eluolu puudutava

info objektiivsete biomarkeritega, et välja selgitada krooniliste haiguste, põletikuliste protsesside ja südameprobleemide riski.

Euroopa Komisjon käsitleb SHARE andmebaasi võtmeallikana riikide sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse poliitikate mõju hindamisel ja muutmisotsuste langetamisel. Nii näiteks hakkab Maailemapank hindama muuhulgas SHARE andmete alusel vanemaealise rahvastiku hooldusvajadust ja hoolduskoormust ning Euroopa Sotsiaalkaitse Komitee kaalub võimalust kasutada SHARE andmeid aktiivsena vananemise indeksi kohalikul tasandil rakendamiseks. Andmebaas on tasuta kättesaadav kogu maailma teadlaskonnale ja nii võib Eesti andmeid leida sadade uurijate teadustöödest, mille tulemusi saame ka meie kasutada.

SHARE Eesti uuringu kahe laine (2011 ja 2013) tulemuste kohta ilmunud eestikeelne kogumik „Pilk hallile alale” on kättesaadav aadressil www.tlu.ee/share-esimene (vt Sakkeus ja Leppik 2016). Kogumiku 12 artiklit keskenduvad Euroopa võrdlusandmete taustal Eesti 55+ rahvastiku kahele suuremale teemale – tervisele ja aktiivsele tegevusele.

Tervise enesehinnang ja tegevuspiirangud

SHARE Eesti tulemuste kogumiku mitmes artiklis tõuseb rahvastikurühmadest esile välispäritolu rahvastiku halvem positsioon põlisrahvastikuga võrreldes. Tervisenäitajate suurte erinevuste põhjuseks on tavaliselt haridus, kuid nimetatud kahe rahvastikurühma haridustasemed on Eestis sarnased. Seetõttu peaks tervisekampaaniate tegemisel oluliselt rohkem tähelepanu pöörama just info edastamise kanalitele ja keelele (Kunder jt 2016). Teavituskampaania väljatöötamisel on vaja arvestada, kuidas kõnetada vähese haridusega mehi, mil viisil mõjutada neid tihedamini tarbima puu- ja köögivilju ja

piimatooteid ning vähem alkoholi- ja tubakatooteid. Lisaks on oluline arvestada meeste ja naiste riskikäitumise trendide erinevusi, sest näiteks täiskasvanud naiste seas on igapäevasuutsetajate osakaal viimase kümne aasta jooksul vähenenud aeglasemalt kui meeste seas. Näeme ka, et edendades eakate liikumist kasvõi vähehaaval sellise koormuseni, mida võib nimetada mõõdukaks või tugevaks, vähendab see üle 60aastaste seas suremust ligikaudu 22% ning on seega kuluefektiivne sekkumise viis.

Uuringutest on teada, et tõsiste terviseprobleemide ja suremuse tõenäosust ennustab kõige paremini eeskätt inimese enda arvamus oma tervises seisundist ehk tervise enesehinnang. Kui arvestada rahvastiku sotsiaal-demograafilisi erisusi, siis mõjutab riskantne tervisekäitumine oluliselt inimese enesehinnangut. Eestis on tõenäosus, et inimene hindab oma tervist halvaks, suitsetajatel; inimestel, kes on kehaliselt aktiivsed harva või üldse mitte ning inimestel, kes tarbivad harva puu- ja köögivilju, kaunvilju ja munatooteid.

Vaagides vanemaealiste tervises seisundi muutusi kahe laine vahel, ilmnes, et vaid veerand nendest inimestest, kes neljandas laines olid ilma igasuguste tegevuspiiranguteta, olid seda ka kahe aasta pärast (Abuladze 2016). Võrreldes selle rahvastikurühmaga, kellel on kahe aasta jooksul tervisepiirangud püsinud muutumatuna, on tervena püsimise tõenäosus suurem üksielavatel, kõrgharitudel, töötavatel ja suuremaarvulise suhtlusvõrgustikuga inimestel.

Kahe laine vahel on iga kuuenda inimese tervises seisund paranenud: piirangud igapäevategevustes on vähenenud või on need täielikult kadunud. Tõenäosemalt esineb selline muutus neil inimestel, kellele on iseloomulikud samad tunnused, mis tervena püsinud rahvastikulgi. Lisanduvad need, kes

on saanud oma lähedastelt sotsiaalset abi või kellel ei ole pikaajalist kroonilist haigust.

Võrreldes muutumatuna püsinud tegevuspiirangutega inimestega on piirangud tekkinud või muutunud tõsisemaks samuti ligikaudu igal kuuendal inimesel. Tõenäosemalt on toimunud see põlisrahvastikuga, töötavate, maal elavate ning nendega, kel varem ei olnud pikaajalist haigust ning isegi neil, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud abi. Kahte viimast tunnust võib interpreteerida ehk nii, et inimesed ei pöördu õigel ajal arsti juurde ja abi saamine osutab sellele, et piirangud on kujunenud tõsiseks.

Tõenäosus kahe laine vahelisel perioodil surra oli ligikaudu 2,5 korda suurem meestel ja neil, kes olid kodused (ka haiguse tõttu koju jäänud); kel ei olnud varem pikaajalist haigust; kes polnud varem abi saanud ning neil, kellel puudus sotsiaalne võrgustik. Seega kõrgendatud tähelepanu nõuavad just need vanemaealiste rühmad, kelle puhul kõrgenenud suremusrisk viitab olulistele vajaka jäämistele tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis. Inimestele, kes on elanud ilma pikaajaliste haigusteta, ei pruugi õigeaegne arstiabi olla kättesaadav; piisavat tähelepanu ei osutata vigastusriskidele; oluline risk on abita jäämine ning elamine ilma ühegi lähedaset.

Vaimne tervis

Ka elukvaliteedi kirjeldamisel töötavad subjektiivsed tervisetunnused paremini kui objektiivsed. Kõige tugevama mõjuga on tervise enesehinnang, samas terviseprobleemide hulk on praktiliselt tähtsusetu; mälu enesehinnang on olulisem kui meenutatud sõnade arv; tunnetatud tegevuspiirang olulisem kui käte ja jalgade võimekus (Saks ja Tiit 2016). Objektiivsetest tervisetunnustest mõjutajad elukvaliteeti kõige rohkem depressiivsus ja võime tõusta toolilt. Eesti jaoks tõstab see tähelepanu keskmesse vajaduse hoopis

suuremal määral tegeleda vanemaealiste igapäevategevuste piirangutega, nooremate inimeste puhul käsitleb neid piiranguid osaliselt töövõimereform. Eesti jaoks hakkavad täit tähelepanu nõudma vanemaealiste vaimse tervise probleemid, mille esmaseks näitajaks on depressiooni kõrge tase.

Depressiooni kriteeriumidele (EURO-D) vastavaid inimesi 55+ vanuses Eesti rahvastikus oli 2011. aastal 42% (Laidra 2016) ja SHARE riikide seas on Eesti selle näitajaga esimesel kohal.

Depressiivsuse kõrge levimusega maades, mille hulgas olid valdavalt Ida- ja Lõuna-Euroopa riigid, oli depressiivsete inimeste osakaal enam kui kaks korda suurem kui madala levimusega maades, kuhu kuulusid Kesk- ja Põhja-Euroopa riigid. Depressiooni oli rohkem naistel, madalama haridustasemega vastajatel, ilma abikaasa/elukaaslaseta elanud vastajatel, välispäritolu vastajatel ning vastajatel, kes ei töötanud. Kui muud sotsiaal-demograafilised tunnused on võrdsed, ei erine kõige vanem rühm depressiivsuse poolest 55–64aastastest, samas on 65–74aastaste hulgas vähem depressiooni kui 55–64aastaste seas.

Kahe uurimislaine vahel oli suurem tõenäosus depressiivsuse suurenemiseks naistel, kõige vanema vanuserühma vastajatel, madalama haridustasemega vastajatel ja välispäritolu vastajatel. Depressiooniriski kahekordistas ka partneri lahkumine kahe laine vahel (kas lahkuminek või partneri surma tõttu). Kui üldiselt olid hõiveseisundi ja depressiooni vahelised seosed ebaolulised, siis kahe laine vahel töötamise lõpetanud vastajad muutusid pigem vähem depressiivseks, mida võib seletada tööst tulenenud stressi kadumisega.

Vanemaealiste depressioon on sageli aladiagnoositud ja -ravitud, sest jääb tervishoiutöötajate jaoks somaatiliste haiguste varju. Samas raskendab ravimata depressioon

somaatiliste haiguste kulgu, suurendab tervishoiuteenuste kasutamist ja kulutusi tervisele. Probleemiks võib olla ka see, et vanemaealised ise ei märka ega tunnusta depressiooni. Vaimse häirega kaasnevad tihti eelarvamused ja stigma, mis takistavad inimesi abi otsimast. Eriti sügavalt võivad eelarvamused olla juurdunud just vanemate põlvkondade esindajatel, kes on suure osa oma elust elanud nõukogude võimu ajal. Sellele viitab kaudsest see, et vanemates vanuserühmades oli märkimisväärselt vähem inimesi, kes vastasid, et neil on elu jooksul depressiooni olnud. Neist inimestest, kes varasemat depressiooni tunnistasid, oli vaid kolmandik seda perearsti või psühhiaatri juures ravinud.

Kui üldiselt võis märgata seaduspära, et kõrge depressiooni tasemega riikides olid kognitiivsete testide tulemused nõrgemad, siis Eesti oma kõrge depressiivsuse, kuid keskmise kognitiivsete võimete tasemega erines sellest mustrist (Laidra 2016). Eesti vastajate keskmine vaimsete võimete skoor erines statistiliselt oluliselt kõigi teiste SHARE riikide keskmistest ning need erinevused ei olnud seletatavad valimite soolise, vanuselise ja haridusliku struktuuri erinevustega. Uuringud on üsna üksmeelselt näidanud, et pensionile jäädes inimeste vaimne võimekus langeb. Kui pingutus väheneb, siis võimed taanduvad. Seetõttu tuleb kasuks tegeleda pensionipõlves kognitiivset stimuleerimist pakkuvate tegevustega.

Sotsiaalne aktiivsus

Eesti inimeste suhteliselt kõrge haridustase ja keskmisel tasemel sooritatud kognitiivsete võimete testid ei ole aga aidanud kaasa sellele, et eestimaalased toetaksid oma vaimset ja füüsilist tervist sotsiaalse aktiivsuse ja enesearendamisega (Tambaum 2016). Eesti 55–64aastastest inimestest kasutab interneti regulaarselt vaid 57% ning vanemas vanuserühmas on kasutajaid

22%. Kursustel osalejaid on pensionialiste seas 4%. Mittetöötavate inimeste klubilises tegevuses osalemise määr on Eesti meestel 5 ja naistel 2,5 korda väiksem kui Euroopa eakaaslastel.

Kõige suuremad erinevused Eesti ja ülejäänud SHARE riikide vahel ilmnevad interneti kasutamises meeste vanuserühmas 55–64. Selles vanuses Eesti meestest ei kasuta regulaarselt interneti 50%, ülejäänud riikides aga ainult 30%. Eesti mehed eristuvad interneti mittekasutamise poolest ka vanusegrupis 65–74. Naiste näitajad Eesti ja teiste riikide vahel erinevad vähem. Interneti mittekasutamise peamine põhjus on oskuste puudumine, mis omakorda tuleneb motivatsiooni vähesusest.

Millised objektiivsed tegurid mõjutavad vanemaealiste kogukondlikku aktiivsust? Eestis ei ole olulist erinevust kogukondlikes tegevustes osalemisel linnas ja maal. Ka SHARE teistes riikides ei ole elukoha tüüp oluline. Samal ajal on Eestis tunduvalt vähem kogukondlikult aktiivseid inimesi rahvastiku selles osas, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Kogukondlikku aktiivsust mõjutab see, kas inimene on tööga hõivatud või ei. Eestis on inimesed, kes pole tööga hõivatud, ka kogukondlikult vähem tegusad, nende seas on aktiivseid vaid 26%. SHARE teistes riikides on mittetöötavatest inimestest aktiivseid 53%, meil iseloomustab sama näitaja aktiivsete osakaalu tööga hõivatute seas. Üks määravaid tegureid kogukondlikes tegevustes osalemisel on inimese haridus, kuid samas isegi kõrgharidusega inimestest vaid 54% on kogukondlikult aktiivsed, kusjuures sama näitaja SHARE teistes riikides on 75%.

Eestis on kahe laine vahelisel ajal näha tegelejate arvu vähenemist kõigi tegevuste puhul. Absoluutarvult on kõige suurem langus toimunud klubilisest tegevusest osavõtjate arvus. Samal ajal on klubiline tegevus

see tegevusliik, kus on olnud kõige vähem loobujaid, mis tähendab, et osavõtjate arv langeb seetõttu, et uusi klubilise tegevusega liitujaid on vähe. Kogukondlikust tegevusest loobunud inimeste hulka kuulub rohkem pigem noorema vanusegrupi esindajaid. Alg- ja keskhariidusega inimestel, võrreldes kõrgema haridusega inimestega, on väiksem tõenäosus kaotada kogukondlik tegevus, kui nad on sellesse juba kaasatud.

Vananeva rahvastiku võtmeküsimused Eestis

Lihtsustatult võib öelda, et meie jõudmine nende riikide hulka, kes just vananemise kaudu on suutelised ühiskonda innovaatiivselt arendama, on Eestis määratud meeste elueaga. Vaadates kolmandas elufaasis¹ inimeste järjest suurenevat osakaalu Euroopa riikides ja Eestis, näeme, et Eesti jõuab esimeste tasemele alles aastatel 2045–2050. Pikemat aega kujunenud hariduslõhe meeste kahjuks ning eriti tervisekäitumise mitmed aspektid (riskikäitumine seoses tubaka ja alkoholiga, vanemaealiste kehaline aktiivsus, värske köögivilja kättesaadavus ning valkude teadlikum tarbimine) nõuavad just meeste puhul erilisi meetmeid. Eestile on iseloomulik ka vanemaealiste meeste eemalejäämine ühistevusest ja õppimisest. Naiste puhul on vaja kampaaniatega enim tähelepanu suunata suitsetamise ja alkoholitarbimise mõjudele.

Näeme, et Eesti on oma rahvastiku arengus ning eeskätt perekondlikus ja leibkondlikus arengus sellises faasis, mis sarnaneb Põhjamaadega, mitte aga Ida- ja Lõuna-Euroopa maadega, kuhu näime kuuluvat mõnede teiste näitajate poolest. Leibkondlikus käitumises on toimunud iseseisvumine, millele viitab üksielavate vanemaealiste

kõrge osakaal. See viitab asjaolule, et ka siis, kui inimest tabavad vanas eas olulised tegevuspiirangud, ei sobi tal minna elama oma laste juurde, vaid tekib hoopis vajadus erapooletu ja professionaalse hooldustoe järele. Viimaseks aga napib raha nii inimestel kui riigil, mida näitab Eesti koht kõrgeima materiaalse ilmajäetusega SHARE riikide hulgas. Sellise rahvastikuarengulise käitumise on vastuolus suuresti vaid perekonna olule pandud hoolduskohustus, mille tõttu kasvab tõsiste tegevuspiirangutega inimeste katmata vajaduste osakaal ning ilma omaste võrgustikuta ja viimases hapruse faasis laste juurde elama viidud inimeste suurem tõenäosus surra.

Tänapäevaste arengute juures ei saa me rahvastiku vananemist mõõta üksnes kronoloogilise vanusega. Seetõttu on arutelud elueaga kohandatud näitajate kasutamisest väga olulised. Arvestades Eesti rahvastiku madalat tervena elatud eluiga ning meeste ja naiste oodatava eluea suurt erinevust, võib osutada vajalikuks jälgida ka seda eluea perioodi, mille vältel on inimene oma tervise tõttu igapäevategevustes piiratud. Aastal 2014 oli see keskmiselt 22 aastat enne surma (meestel üle 19 ja naistel üle 24 aasta). Mitmed uurijad on toonud välja, et vananemine ei ole probleem neis riikides, kus on palju eakaid kronoloogilise vanuse järgi, vaid neis maades, kus on palju hapruse faasis eakaid.

Definitsiooni järgi jõuab inimene oma elutee hapruse faasi siis, kui minimaalne stressor käivitab mitmete füsioloogiliste süsteemide kokkuvarisemise. Hapruse faasi ennustavad ette käesurve näitaja (Syddal jt 2003), aga ka kognitiivse funktsiooni oluline halvenemine (Skirbekk jt 2012). Rahvastiku tasemel on olulised just need kaks näitajat, mille alusel

¹ Kolmandas elufaasis inimesel puudub vajadus tööl käia (ehk tal on sissetulek olemas) ja ta saab iseseisvalt, ilma kõrvalabita hakkama. 100–150 aastat tagasi oli selliste inimeste osakaal elanikkonnas väga väike.

hinnata kõige suurema abi vajajate rühma ning prognoosida igapäevaste tugiteenuste mahtu. On huvitav esile tuua, et mõlema näitaja puhul ei kuulu Eesti suure riskiga rahvaste hulka, vaid jääb pigem SHARE keskmiste riikide tasemele. Olgugi, et vanuserühmade vahel on näha kognitiivsete võimete olulist erinevust, on kahe laine vahel võimete langus olnud väike. Riikide vahelise erinevuse põhjuseks peetakse erinevaid elutingimusi, sh toitumist, haiguste esinemist, võimalusi kehaliseks ja sotsiaalseks aktiivsuseks, aga ka haridustee pikkust ja kvaliteeti.

Andmed inimeste eluteel kogetu kohta aitavad paremini mõista, kas Eestis, kus üldiselt on tervise akumulieritud näitajad halvemad, on ka hapruse faasi saabumine varasem ja pikem. Seetõttu on algavas seitsmendas laines (2016–2018) läbiviidav ühekordne eluteeuuring oluline sisend SHARE longituudandmetele. Elutee olulised sündmused aitavad prognoosida ka seda, kas nooremad põlvkonnad, kes sisenevad vanemasse ikka, on viimase 25 aasta jooksul suutnud saavutada parema tervise ning kas seetõttu võib loota, et tulevikus saabub hapruse faas hiljem. **S**

Eestis on SHARE andmete kasutamise võimalus kõigil huvilistel

SHARE andmebaasi kasutamise õigus on ainult teadusasutuste töötajatel. Andmetele ligipääsuks tuleb täita taotlusvorm (www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/SHARE_Data_Statement.pdf).

Lisaks mahukale andmebaasile on võimalik kasutada ka kahemõõtmelist andmetabelit EasySHARE, mis sisaldab kõigi SHARE riikide kõigi vastajate viie laine reaalseid puhastamata ja agregeerimata ehk eri tunnuste alusel koondamata andmeid. Lihtsustatud andmetabel on töövahend statistiliste meetodite õpetamisel kõrgkoolides, mis tutvustab samas SHARE andmebaasi võimalusi.

SHARE Eesti tervise valdkonna andmete standardtabelid on avalikult kättesaadavad TAI veebis (www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused/3457-euroopa-tervise-tooajatu-ja-vananemise-uuring-share) ning elamistingimuste, sotsiaalsete võrgustike ja hõive näitajad on avaldatud Statistikaameti andmebaasis (www.stat.ee/50166/?highlight=SHARE). TAI andmebaasis on avaldatud ka longituudsed andmed, mida pole seni tehtud üheski avalikus andmebaasis.

SHARE andmete alusel koostatud teaduspublikatsioonid on koondatud SHARE kodulehele (www.share-project.org/publications.html). Ilmunud enam kui 4800 artikli seas on 1800 artiklit, mis on ilmunud ajal, kui oli võimalik kasutada ka Eesti andmeid.

Eesti autorite teaduspublikatsioonid on kättesaadavad SHARE Eesti kodulehel (<http://share-estonia.ee/index.php?id=19>)

Viidatud allikad

- Abuladze, L.** (2016). Tegevuspiirangutega rahvastiku seisundimuutus Eestis aastatel 2011–2013. Kogumikus: Sakkeus, L., Leppik, L. (toim.) Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks, 97–108.
- Kunder, N., Abuladze, L., Vaask, S., Lang, K.** (2016). Tervisehinnang ja tervisekäitumine. Kogumikus: Sakkeus, L., Leppik, L. (toim.) Pilk hallile alale, SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks, 29–46.
- Laidra, K.** (2016). Vaimne ja kognitiivne tervis. Kogumikus: Sakkeus, L., Leppik, L. (toim.) Pilk hallile alale, 73–96.
- Sakkeus, L., Leppik, L.** (toim.) (2016). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks, 1–257.
- Saks, K., Tiit, E.-M.** (2016). Tervise subjektiivsed ja objektiivsed hinnangud. Kogumikus: Sakkeus, L., Leppik, L. (toim.) Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks, 47–72.
- Tambaum, T.** (2016). 55+ rahvastiku internetikasutus ja sotsiaalne aktiivsus. Kogumikus: Sakkeus, L., Leppik, L. (toim.) Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks, 183–206.
- Syddal, H., Cooper, C., Martin, F., Briggs, R., Sayer, A. A.** (2003). Is grip strength a useful single marker of frailty? *Age and Ageing* 32, 6, 650–656.
- Skirbekk, V., Loichinger, E., Weber, D.** (2012). Variation in cognitive functioning as a refined approach to comparing aging across countries. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109, 3, 770–774.